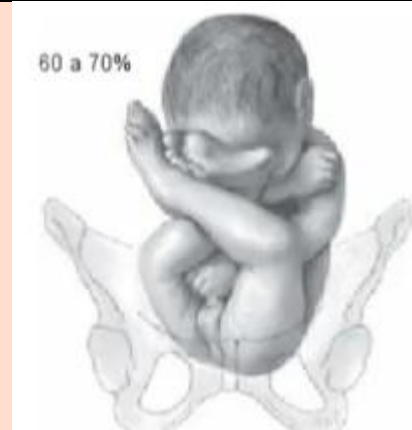
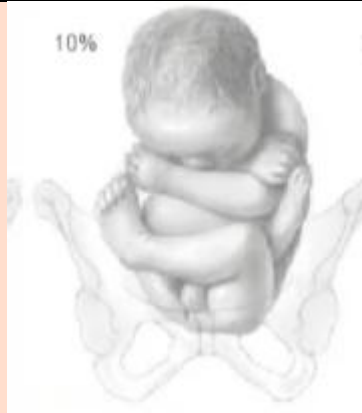


- Presentación pélvica puede persistir en el 2 – 5% de los casos
- 37 -38 SDG puede hacer la rotación solo, si no se realiza lo probable es que quede en esta posición anormal y se programa una cesárea a las 39 SDG

CLASIFICACIÓN:

Franca	Completa	Incompleta
 60 a 70%	 10%	 20% a 25%
Extremidades flexionadas en las caderas y extendidas en rodillas (pies en cabeza)	Ambas caderas flexionadas o una o ambas rodillas también lo están.	Una o ambas caderas están extendidas, uno o ambos pies quedan debajo de las nalgas y otro en una parte más baja del canal de parto “presentación en pies”

Posición del cuello (hiperextensión)

- **“Feto que mira a las estrellas”** → Hiperextensión extrema 5%
- **“Feto volando”** → situación transversa con hiperextensión
- Más común anomalías fetales o uterinas
- **Riesgo de lesión medular espinal cervical** → cesárea

DIAGNOSTICO:**Factores de riesgo:**

- Situación fetal frecuente lejos del termino
- Estas condiciones pueden interferir con la rotación normal del feto hacia presentación cefálica.

Maternos:	Fetales	LA
• Anomalías uterinas • Multiparidad • Edad materna avanzada • Placenta previa • Parto pélvico previo	• Prematuridad • Tamaño pequeño para la edad • Malformaciones fetales • RCI • Género femenino	• Polihidramnios • Oligohidramnios

Historia clínica:

- Sensación que los movimientos fetales predominan en la parte inferior del abdomen.
- Dolor intenso en hipocondrios (región subcostal)



Exploración física:

Maniobras de leopold			
1ra	2da	3ra	4ta
Cabeza fetal redonda que ocupa el fondo uterino.	Espalda dura y ancha a un lado del abdomen y las pequeñas partes nodosas en el otro	Si el feto no está encajado, la pelvis blanda es movable por arriba del estrecho pélvico superior.	Tras el encajamiento, la pelvis se palpa por debajo de la sínfisis del pubis; la exactitud de la palpación puede variar



Tacto cervical		
Pelvis franca	Pélvica completa	Presentación de pie:
No se palpan los pies, se palpan tuberosidades isquiáticas, sacro y ano fetal. Con más descenso pueden palparse genitales externos	Pies junto a las nalgas	Uno o ambos pies debajo de las nalgas

Con dificultad en trabajo de **PARTO PROLONGADO** → Se puede confundir cara con pelvis.

¿Cómo diferenciar cara de pelvis?

- **Ano:** Resistencia muscular; puede manchar el dedo con meconio.
- **Boca:** Se sienten mandíbulas y paladar óseos.

Distribución:

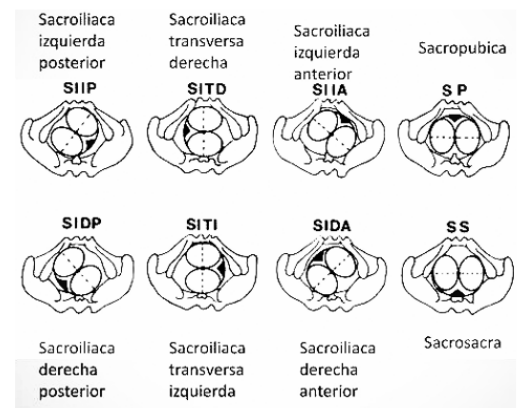
- **Boca + eminencias malares:** Forman triángulo.
- **Ano + tuberosidades isquiáticas:** Forman línea recta.



Tacto vaginal:

Determinación de la posición: Se palpa el sacro fetal, y la posición se describe según su relación con la pelvis materna:

- **SIA:** Sacro izquierdo anterior.
- **SDA:** Sacro derecho anterior.
- **SIP / SDP:** Sacro izquierdo posterior / sacro derecho posterior.
- **SIT / SDT:** Sacro izquierdo transverso / sacro derecho transverso



VÍA DEL PARTO:

Factores a considerar:

- Paridad y dimensiones pélvicas de la madre
- Complicaciones del embarazo
- Experiencia del profesional
- Preferencia de la paciente
- Capacidades del hospital
- Tamaño, anatomía y edad gestacional

Considerar que tanto en fetos a término como pretermino tienen ventajas mayores con el parto por cesárea, relacionadas con menor riesgo de mortalidad perinatal y morbilidad neonatal "grave" como anoxia, traumatismo y atrapamiento de cabeza.

Criterios para parto vaginal:

El parto vaginal en presentación pélvica solo debe intentarse en casos cuidadosamente seleccionados, debido al mayor riesgo de complicaciones fetales durante el nacimiento.

- **Feto único:** Los embarazos múltiples aumentan el riesgo de complicaciones durante el descenso y la extracción fetal.
- **Peso fetal 2,500–3,800 g:** Fetos con peso mayor a 3,800–4,000 g incrementan el riesgo de atrapamiento de la cabeza fetal y distocia.
- Pelvis materna adecuada
- Cabeza fetal flexionada : extensión aumenta riesgo de atrapamiento cefálico y trauma fetal



Contraindicaciones (Factores que favorecen el parto por cesárea)

Características clínicas

Falta de experiencia del operador
Solicitud de la paciente de un parto por cesárea
Muerte perinatal o traumatismo neonatal al nacer previos

Características maternas

Contracción pélvica o forma pélvica desfavorable identificada por exploración clínica o pelvimetría
Parto por cesárea previo

Compiladas de las referencias del texto.

Características ecográficas fetales

Feto grande: >3 800 a 4 000 g
Restricción grave del crecimiento fetal; peso al término <2 500 a 2 800 g
Oligohidramnios
Anomalía fetal incompatible con el parto vaginal
Presentación pélvica incompleta
Cuello hiperextendido
Feto de pretérmino viable, en apariencia sano con trabajo de parto activo o indicación para el parto

→ Anomalías fetales como hidrocefalia o anencefalia

Complicaciones del parto:

Maternas	Fetal	
- Mortalidad - Laceraciones genitales, vaginales o cuello uterino - Extensión de episiotomía – desgarros profundos con riesgo de infección.	- Mortalidad - Prematuras y sus complicaciones - Prolapso del cordón - Anomalías congénitas - Fracturas humerales o clavicular - Lesión de plexo braquial	- Trauma del ECM - Separación de epífisis escapular, humeral o femoral - Lesión de medula espinal - Fractura de vertebras - Displasia de cadera

Estudios de imagen:

Ecografía	Radiografía simple	
- Transabdominal en plano sagital para presentación - Anormalidades macroscópicas como hidrocefalia o anencefalia - Tamaño y grado de flexión del cuello fetal	Define inclinación de la cabeza fetal	

Pelvimetría:

a valorar la pelvis ósea materna por TAC (puede ser por RM o Rx)

AP del ES	Diámetro transversal de EPS	Distancia interespinosa
>10,5 cm	>12.0 cm	>10 cm

Otros consideran la biometría materno fetal.

TRABAJO DE PARTO Y PARTO:

Preparación del trabajo de parto:

- En TOCO se inicia la monitorización de la FCF y las contracciones uterinas
- Se llama a médico, ayudante, personal de anestesia y personal de reanimación neonatal
- Valoración de dilatación, estado de membranas y estación de presentación
- Completar valoración ecográfica

Durante el trabajo de parto:

- Atención continua por riesgo de prolapso de cordón
- FCF cada 15 minutos

- **ROMPIMIENTO DE MEMBRANAS:** riesgo de prolapso de cordón aumenta (menor con prematuros, atención en FCF en los primeros 5 – 10 min)
- Analgesia epidural – inhalación con ON + O2 alivia adicionalmente el dolor
- Cuando se observa el feto se alienta el pujo

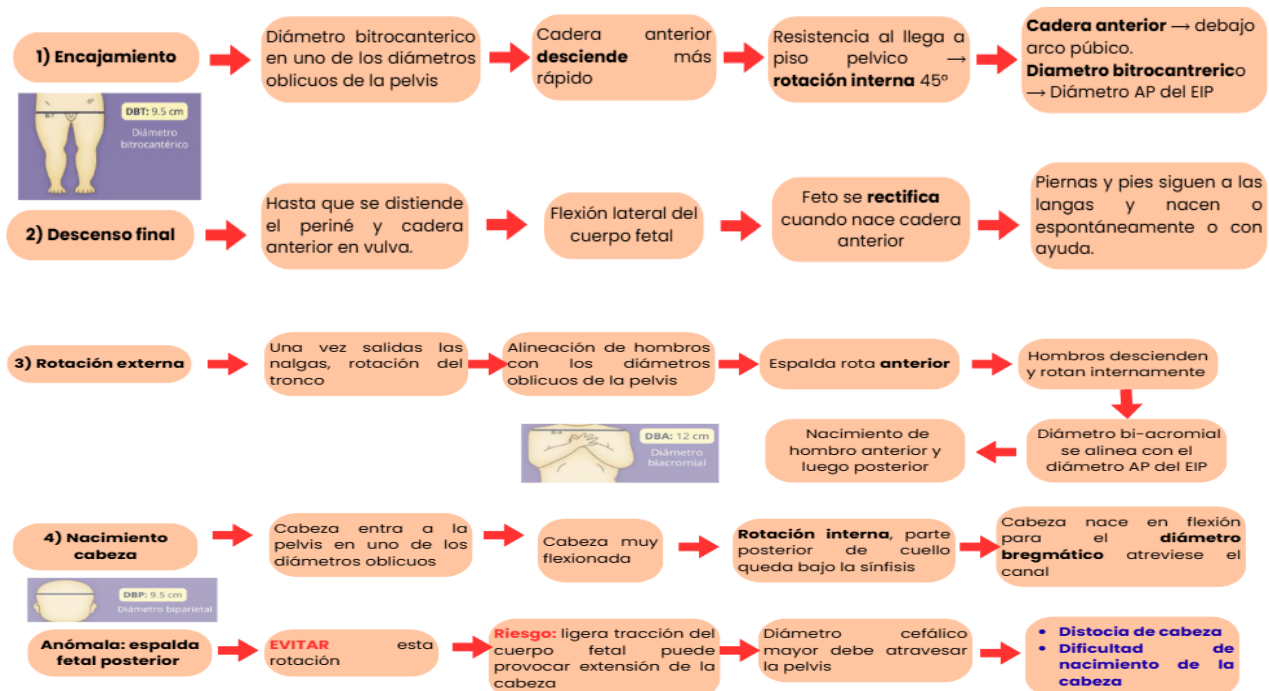
Inducción o aumento de trabajo:

Aunque el trabajo de parto pélvico avanza con lentitud se recomienda no usarla solo en **CONTRACCIÓNES HIPOTONICAS**, se prefiere uso de cesárea antes que la inducción o aumento farmacológico.

Métodos de parto vaginal

Parto pélvico espontaneo	Extracción pélvica parcial	Extracción pélvica total
Feto se expulsa por completo sin tracción o manipulación. Poco frecuente casi siempre requiere asistencia experta	Feto nace de manera espontánea al OMBLIGO pero el resto del cuerpo mediante tracción o maniobras asistidas con o sin esfuerzo materno	Cuerpo fetal completo es extraído por medico

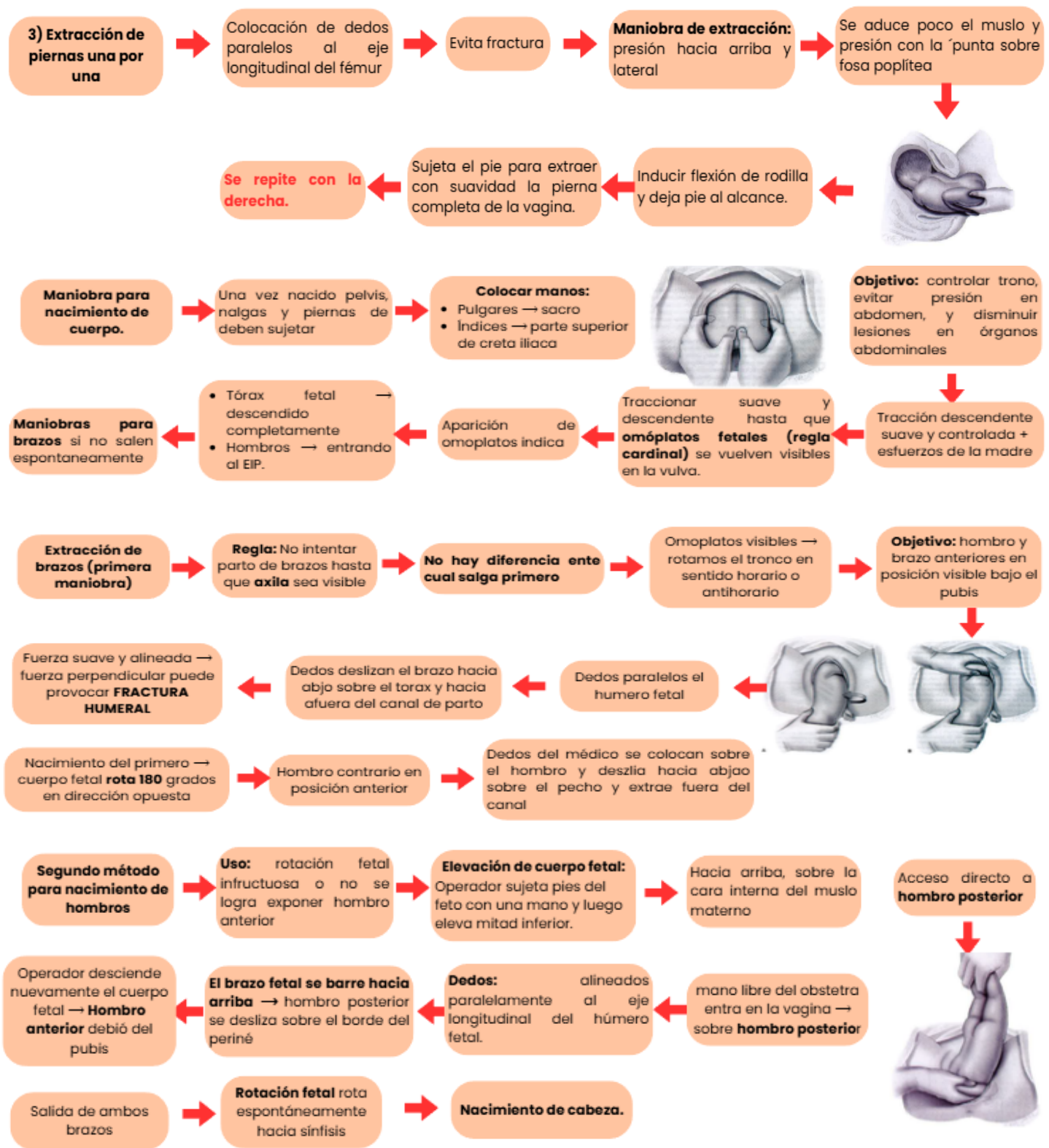
1) Parto pélvico espontaneo



2) Extracción pélvica parcial

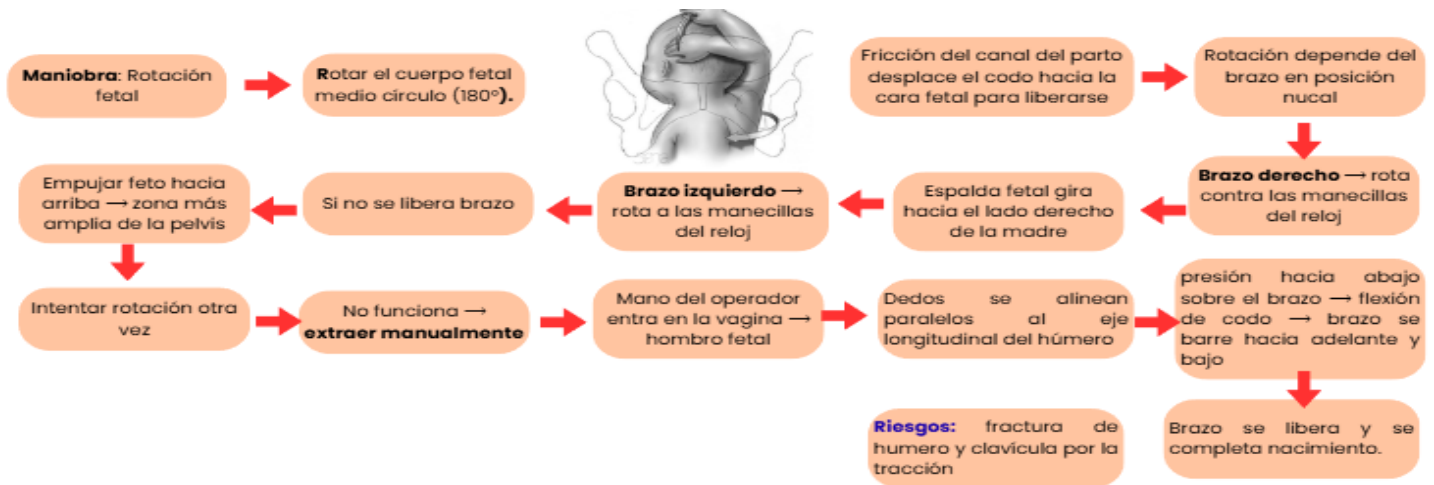
EPISIOTOMÍA: usualmente se realiza siempre, para ampliar el canal y disminuir el riesgo de atrapamiento de la cabeza, se recomienda **MEDIOLATERAL**.





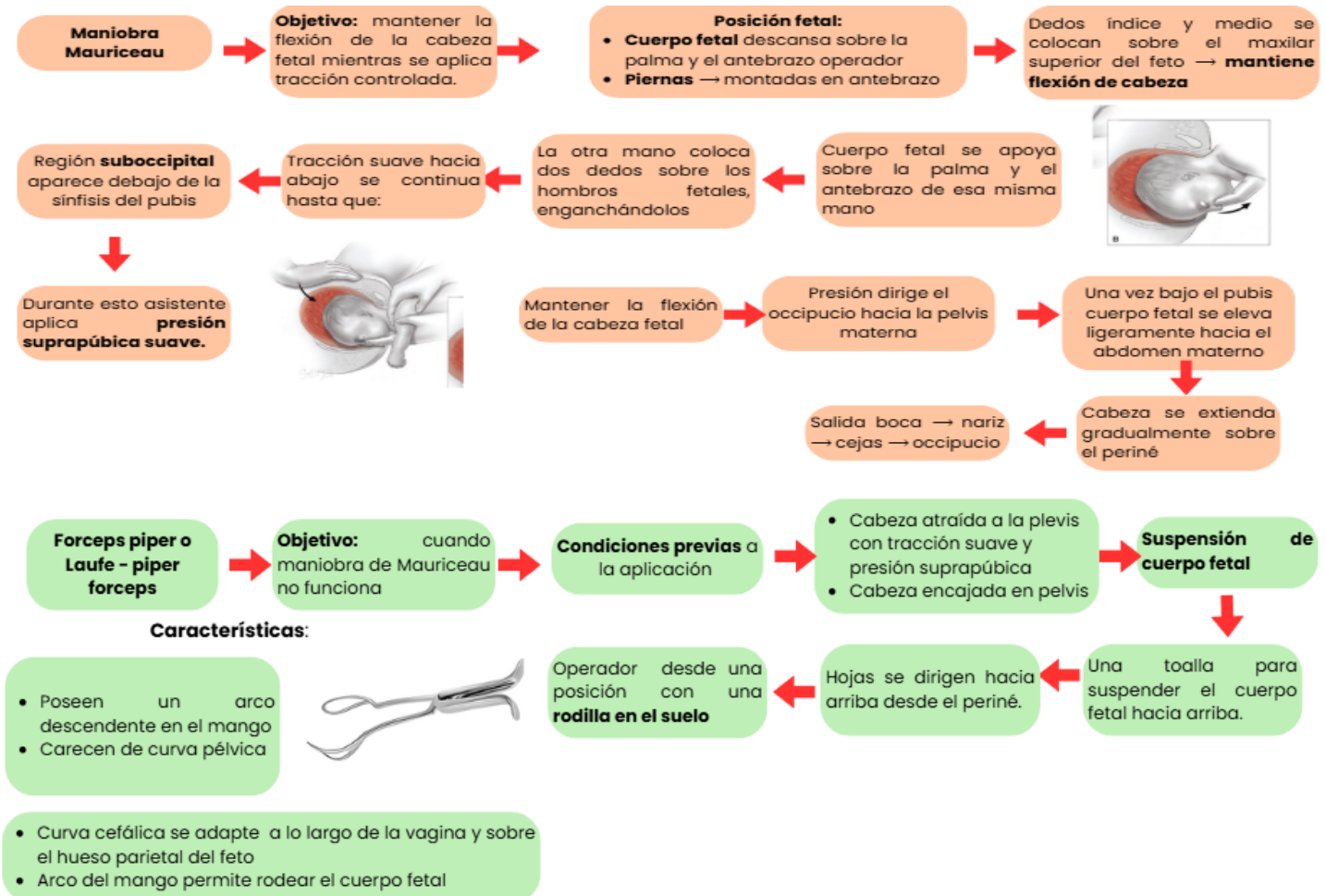
Brazo nuczal:

Se define cuando uno o ambos brazos fetales se extienden pasan por detrás del cuello fetal y quedan atrapados en el estrecho pélvico superior. Esto provoca que: el diámetro biacromial aumente y el parto de los hombros sea más difícil.



Parto de la porción posterior de la cabeza

Puede extraerse mediante **tres maniobras principales**, pero en todas ellas debe evitarse la hiperextensión del cuello fetal





Atrapamiento de la cabeza:

Debido a:

- Dilatación cervical incompleta
- Desproporción cefalopélvica

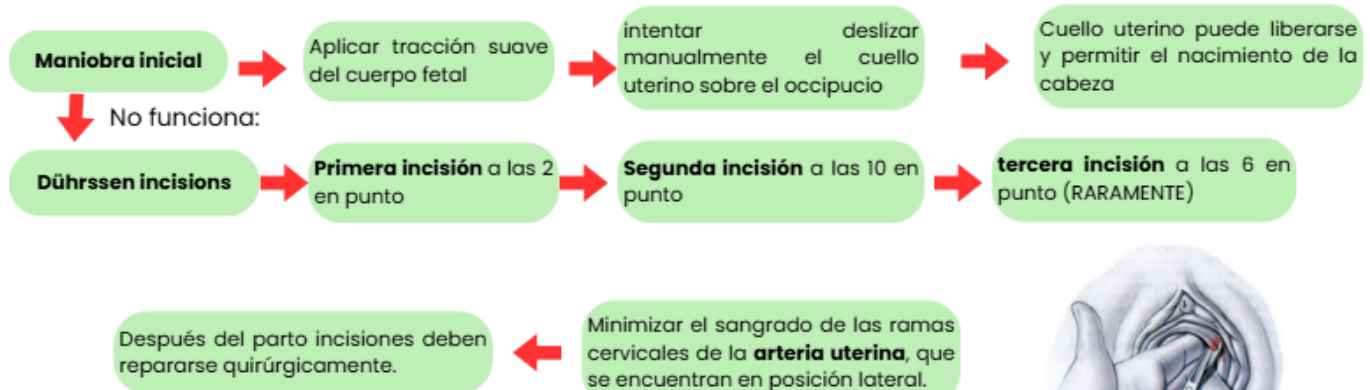
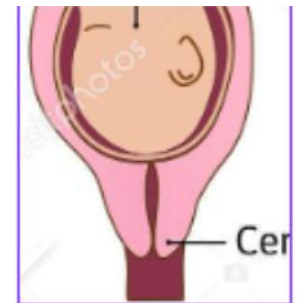
URGENCIA OBSTÉTRICA, ya que debe asumirse **compresión significativa del cordón umbilical**.

Atrapamiento por dilatación cervical incompleta

Esto ocurre con mayor frecuencia cuando:

- El cuello uterino no está completamente dilatado
- El feto es prematuro y pequeño

En esta situación el cuello uterino puede **CONSTREÑIR EL CUELLO FETAL**.





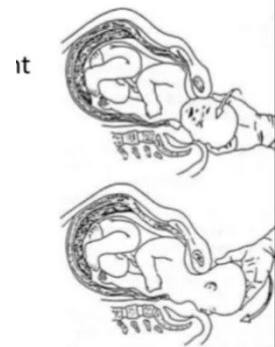
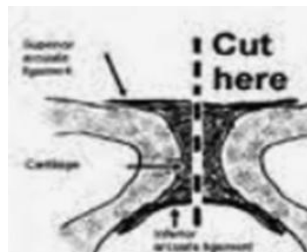
Atrapamiento por desproporción cefalopélvica

Cuando la cabeza superior se detiene por desproporción cefalopélvica, pueden considerarse:

- Zavanelli maneuver
- Symphysiotomy

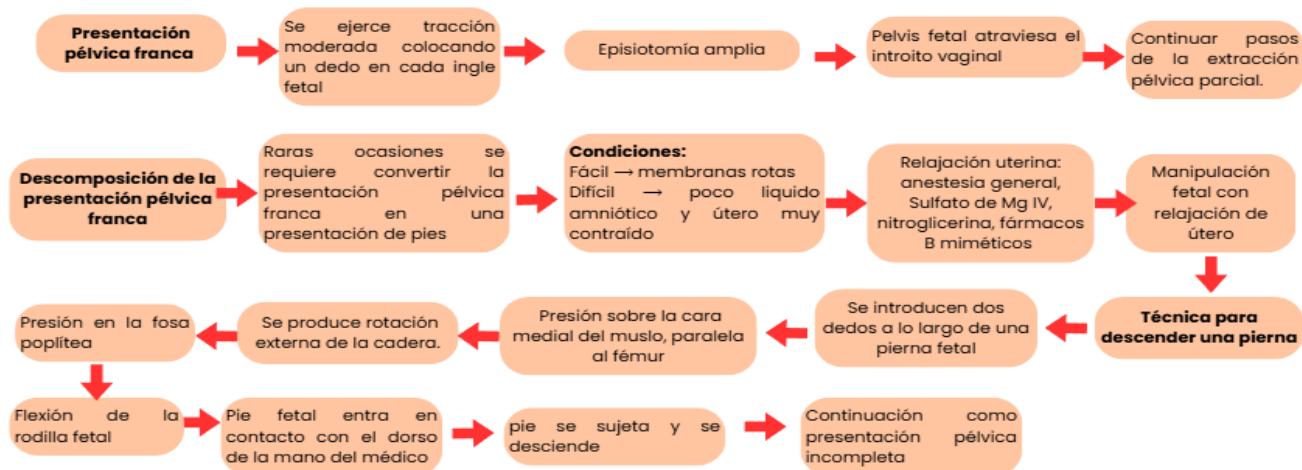
Objetivo

- Aumentar el espacio pélvico o permitir la extracción fetal.



3) Extracción pélvica total

Presentación pélvica franca:



Presentación incompleta o completa

Puede requerirse extracción pélvica total cuando:

- El trabajo de parto progresa rápidamente
- No es posible realizar cesárea a tiempo.



Estas mismas maniobras pueden utilizarse durante el parto por cesárea para facilitar la extracción fetal a través de la incisión de histerotomía en presentaciones:

- Pélvica franca
- Pélvica completa
- Pélvica incompleta.

VERSION CEFALICA EXTERNA:

Consiste en modificar la **presentación fetal** mediante manipulación, sustituyendo un polo fetal por otro o convirtiendo una situación oblicua o transversal en una longitudinal.

Tipos	
External cephalic version:	Internal podalic versión
Manipulación a través de la pared abdominal para convertir la presentación en cefálica.	Manipulación dentro de la cavidad uterina para producir presentación pélvica, usada principalmente para el segundo gemelo.

Indicaciones:

Momento ideal después de las **37 SDG**, debido a que:

- Mayor volumen de líquido amniótico, lo que facilita el giro fetal.
- Se reduce el riesgo de prematuridad si se induce parto
- Antes de este momento, muchas presentaciones pélvicas se corrigen espontáneamente.
- Si se realiza demasiado temprano, el feto puede volver a posición pélvica.

Antes de las 37 SDG: aumenta el riesgo de parto prematuro tardío.

Contraindicaciones:

Absolutas	Relativas
• Parto vaginal no es posible, por ejemplo: • Placenta previa • Embarazo multifetal	• Trabajo de parto temprano • Oligohidramnios • Premature rupture of membranes • Cordón nual conocido • Anomalías uterinas estructurales

	- Fetal growth restriction - Antecedente o riesgo de desprendimiento placentario
--	---

Factores que aumentan el éxito

- Multiparidad
- Presentación no encajada
- Placenta no anterior
- No obesa
- Abundante líquido amniótico

Complicaciones

- Placental abruption
- Preterm labor
- Compromiso fetal

Raros:

- Bradycardia fetal transitoria
- Ruptura uterina
- Hemorragia fetomaterna
- Alloimmunización
- Embolismo de líquido amniótico
- muerte materna o fetal (muy raro)

Técnica:			
Preparación:	Evaluación previa	Recomendaciones	Posición materna
- Acceso IV - Ayuno 6 horas - Líquidos claros hasta 2 hrs antes	- Confirmar presentación - Evaluar volumen LA - Descartar anomalías - Localización placentaria - Orientación de columna	- Monitorizar FCF - Administrar RHO D en RH negativas - Puede usarse tocólisis o analgesia regional	- Inclinación lateral izquierda para mejorar la perfusión uteroplacentaria - Posición de Trendelenburg
Durante la maniobra:	Giro fetal		
- Monitorizar FCF con ecografía - Abundante fel ecográfico para reducir fricción y dolor	- Primero hacia adelante - Mano sostiene la cabeza fetal - Nalgas se elevan de la pelvis materna - Nalgas se desplazan lateralmente	- Se guían hacia el fondo uterino - Simultáneamente la cabeza se dirige hacia la pelvis - Si falla → Giro hacia atrás	
Suspensión de procedimiento	Después de procedimiento:	Manejo de alteraciones de la FCF	Conducta posterior:
- Dolor materno excesivo - Fcf anormal persistente - Múltiples intentos fallidos	- Puede ocurrir versión espontánea posterior - Si exitosa se repite una prueba sin estrés	- Líquidos intravenosos - Oxígeno - Posición lateral	- Si la ecv se realiza antes de las 39 semanas: - Se recomienda esperar el inicio espontáneo del trabajo de parto - Inducción inmediata mayor riesgo de cesarea.

Tocolisis en versión cefálica externa			
Definición:	Fármacos	Procedimiento se inicia:	Efectos fisiológicos:
Antes de intentar la External cephalic version para relajar el útero, lo que facilita la manipulación	Uso de β -miméticos: Terbutalina y Ritodrine	Taquicardia materna leve, un efecto secundario esperado del fármaco.	- Ligero aumento de la FCF. - Transitorio y clínicamente tolerable.

Analgesia de conducción			
Definición:	Porque	Tipos	Riesgos
Durante la External cephalic version puede mejorar las condiciones para realizar la maniobra. **No AUMENTA RIESGOS	Reduce el dolor materno Disminuye la resistencia de la pared abdominal Facilita la manipulación fetal durante el giro.	Anestesia epidural y espinal No hay una técnica superior Se pueden usar: Sedación IV o ON	Cefalea pospunción dural
Moxibustión			
Definición:	Procedimiento:	Objetivo:	Aplicación
Es una técnica de la medicina tradicional china utilizada para intentar corregir la presentación pélvica.	Se quema un cilindro similar a un cigarrillo hecho con artemisia vulgaris (artemisa o moxa). La fuente de calor se coloca: Directamente sobre la piel O sobre una aguja de acupuntura En el punto de acupuntura bl67, ubicado en el pie.	Calor provoca: Aumentar el movimiento fetal Favorecer la versión espontánea a presentación cefálica.	33 – 36 sdg

EXTRAS:

- Descartar placenta previa, miomas
- Malformaciones: hidrocefalia y anencefalia – NO PARTO VAGINAL
- Parto <300 gr se puede parto vaginal
- Si esta ya encajado se puede realizar también, ya que si se sube puede causar desgarros en las arterias
- Podalica: traccionar pies hacia abajo,
- Compresas: se usan para poder maniobrar al bebe por la presencia de grasa que tienen (Resbala)
- Tratamos sacar lo más de cordon que se pueda sin traccionar mucho

Maniobras:

Primero se van a meter los dedos para verficar como se encuentra el bebe y se trata de rotar para despegar el hombro posterior y pasarlo anterior, y luego a lado contrario para despegar el otro.

Luego se toma de la boca y occipucio y se pide que se levanten las piernas y traccionamos al bebe, el levantar las manos es para que aumente el diámetro de la pelvis